

67/M, 상복부 통증 및 황달

DEPARTMENT 소화기내과	LAST UPDATE 2026-06-22 17:30
SUMMARY	ERCP 후 경과 관찰 중인 담석성 담관염/췌장염 의심 환자. 항생제 및 보존적 치료 중.

1 Admission Note

CC	3일 전부터 발생한 상복부 통증과 눈의 노래짐
HPI	내원 3일 전 기름진 식사 후 발생한 상복부 통증으로, 통증은 우상복부와 명치 부위에 국한되며 등으로 방사됨. 동반된 오심/구토가 있었고, 내원 1일 전부터 공막 황달과 진한 소변을 인지함. 발열 동반.
PMH	고혈압 (5년, amlodipine 5mg 복용 중), 당뇨병 (-)
PSH	충수절제술 (20년 전)
Medication	Amlodipine 5mg qd
Allergy	특이 약물 알레르기 없음 (NKDA)
Family history	특이 가족력 없음
Social history	회사원, 기혼
Alcohol history	소주 주 2회, 회당 1병 (약 20년)
Smoking history	20갑년, 현재 흡연 중
ROS	[General] - fever (+): 38.4도 [GI] - nausea (+) - vomiting (+): 2회 - abdominal pain (+): RUQ/epigastric [Hepatobiliary] - jaundice (+) - dark urine (+) [Additional notes] 증상은 식후 악화되는 양상.
Physical examination	V/S: 위 vitals 참조 General: acute ill-looking, 공막 황달(icteric sclera) 관찰 Abdomen: RUQ tenderness (+), Murphy's sign (+), rebound tenderness (-), bowel sound normoactive Extremities: pitting edema (-)
Initial vital signs	BT 38.4 BP 138/86 PR 98 RR 20 SPO2 97% HEIGHT 172 CM WEIGHT 74 kg BMI 25.0
Image/procedure text findings	Abdominal US (ER): 담낭 결석 및 담낭벽 비후 소견, 총담관 확장 (CBD 11mm) 동반.

2 Pre-test Initial Impression

Rank	Impression	Evidence	Against / uncertainty	Missing data	Dx plan	Tx plan
1	급성 담관염 (Acute cholangitis)	발열, 황달, RUQ 통증 (Charcot triad), 담관 확장	혈압 안정적, 의식 명료	혈액배양, MRCP	혈액배양, MRCP/ERCP	광범위 항생제, 수액
2	급성 췌장염 (Gallstone pancreatitis)	Lipase 640 (10배 상승), 상복부 통증	통증이 RUQ 우세	조영증강 CT	복부 CT	금식, 수액, 진통
3	급성 담낭염 (Acute cholecystitis)	Murphy sign (+), 담낭벽 비후	전신 염증이 담관 염에 더 부합	HIDA scan	초음파 추적	항생제, 추후 담낭 절제 고려

3 Lab / Image / Procedure Summary

Lab table

Test	Unit	Ref Range	OPD	Admission	ERCP day	Post-ERCP D1	Interpretation
WBC	10 ³ /uL	4.0-10.0	—	14.2	12.8	9.6	백혈구 증가, 호전 중
Hb	g/dL	13-17	—	14.1	13.8	13.5	정상
Platelet	10 ³ /uL	150-400	—	232	210	198	정상
Total bilirubin	mg/dL	0.2-1.2	—	4.8	5.2	3.1	상승, 폐쇄성 황달
AST/ALT	IU/L	0-40	—	182/210	150/188	92/120	간담도 효소 상승
ALP	IU/L	40-120	—	320	298	240	상승
Lipase	U/L	13-60	—	640	410	180	췌장염 시사
CRP	mg/dL	0-0.5	—	12.4	9.8	5.2	염증 상승

Image findings

Abdominal CT: 총담관 내 결석 의심, 췌장 주위 지방 침윤 소견.

Procedure findings

ERCP: 총담관 결석 제거, EST 및 ENBD 삽입함.

Summary

영상 및 시술 소견상 담석에 의한 담관염 및 췌장염에 합당하며, ERCP로 담관 감압 시행함.

4 Post-test Final Impression

Rank	Impression	Evidence	Against / uncertainty	Dx plan	Tx plan
1	담석성 급성 담관염	ERCP에서 총담관 결석 확인 및 제거, 빌리루빈/ 효소 호전		경과 관찰	항생제 7-10일, 추후 LC
2	담석성 급성 췌장염 (경증)	Lipase 호전, 통증 감소		경과 관찰	식이 진행

5 Problem List

Priority	Problem	Status	Evidence	Notes
1	담석성 담관염	IMPROVING	ERCP 후 빌리루빈/CRP 감소	항생제 D3, ENBD 유지 중
2	담석성 췌장염	IMPROVING	Lipase 640→180	통증 호전, 식이 진행 예정
3	고혈압	ACTIVE	기왕력, BP 138/86	amlodipine 유지
4	흡연	BACKGROUND	20갑년 현재 흡연	금연 교육 필요

6 Progress Notes

2026-06-22 · HD#3 / POD(ERCP)#1

Vitals	BT 37.4 BP 126/78 PR 84 RR 18 SPO2 98%
Diet	금식 → 미음 시작
I/O	I 2400 / O 1900 (소변 1600, ENBD 300)
Overnight event	야간 발열 없음, 통증 NRS 3점으로 호전
Drain/tube	ENBD 유지, 배액 맑은 담즙 양상

SOAP	Problem #1. 담석성 담관염
Status	IMPROVING
S	복통 많이 줄었고 열도 안 남
O	PE 공막 황달 감소, RUQ 압통 경미 Lab T.bil 5.2→3.1, CRP 9.8→5.2, WBC 12.8→9.6 Image / Procedure ENBD 배액 양호
A	ERCP 후 담관 감압으로 임상/검사 호전. 항생제 지속.
P	Dx 내일 추적 LFT Tx Ceftriaxone 유지, 수액 감량 Edu ENBD 관리 교육

SOAP	Problem #2. 담석성 췌장염
Status	IMPROVING
S	메스꺼움 호전
O	PE 상복부 압통 경미 Lab Lipase 410→180
A	경증 췌장염으로 식이 진행 가능.
P	Dx 통증/효소 추적 Tx 미음 → 연식 진행

2026-06-21 · HD#2 / ERCP day

Vitals	BT 38.1 BP 132/82 PR 92 RR 20 SPO2 97%
Diet	금식
I/O	I 2600 / O 1700
Overnight event	ERCP 시행, 시술 후 경미한 복통
Drain/tube	ENBD 삽입함

SOAP	Problem #1. 담석성 담관염
Status	ACTIVE
S	시술 후 복부 불편감
O	PE RUQ 압통 지속 Lab T.bil 4.8→5.2 (시술 직후)
A	ERCP로 담관 결석 제거 및 감압 시행. 경과 관찰.
P	Tx 항생제 지속, 금식 유지